

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

José Luis Miguel Maku Guerra Martínez	
Sexo: Masculino.	Identificación: T.I 1.063.596.890
Fecha de nacimiento: 19/02/2012.	Edad a la fecha: 13 años, 03 meses, 24 días.
Lateralidad: Zurdo.	Escolaridad: Séptimo de básica secundaria.
Acompañante: Sara Guerra.	Parentesco: Hermana.
Entidad: DUSAKAWI EPSI.	Fecha de evaluación: 13/06/2025.

II. MOTIVO DE CONSULTA

"En las pruebas neuropsicológicas arrojó que tenía problemas de atención (TDAH), empezamos las terapias, pero él se retiró. A partir de los 5 o 6 años empecé a decirle que tenía 2 mamás, sin embargo, él me evadía el tema, me decía que no lo confundiera. Con Aty creó una rivalidad, estaban en el mismo salón y él pidió ser calificado como los demás niños, pero como las tareas de Aty son más sencillas, ella sacaba notas de 100 y eso a él le molestaba, a raíz de esa rivalidad, Aty le dijo que él era adoptado, se deprimió, lloraba mucho, no podía dormir, me dijo que quería conocer a su mamá; luego dijo que ya no quería. A veces no duerme, se ha vuelto agresivo, a veces se pone a llorar, pero no quiere que lo veamos llorando. Desde el año pasado, me habla de que escucha unas voces que le dicen que se porte mal. A veces me dice que no entiende por qué está vivo, que prefiere estar muerto. Académicamente no le va bien, es distraído, no sabe que tareas le dejan, si le ponen trabajos en grupo, no sabe quiénes son sus compañeros, tiene mala caligrafía, no toma dictado, su ortografía es pésima, le puedo decir mayo y escribe mapo o ma. La rectora dice que es un problema de actitud. Se frustra cuando le va mal, dice que no quiere defraudar a su madre".

III. HISTORIA DE LOS ANTECEDENTES Y/O ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente masculino de 13 años de edad, que asiste a proceso de evaluación neuropsicológica en compañía de su hermana, reportándose cuadro clínico caracterizado por bajo rendimiento escolar, ritmo de aprendizaje lentificado, desmotivación frente al contexto escolar, dificultades en el funcionamiento de las habilidades curriculares, atención dispersa, fallas mnésicas, irritabilidad, alteración en patrón del sueño, baja tolerancia a la frustración, llanto fácil, dificultades en el seguimiento de instrucciones, conductas de autoagresión (se hala el cabello), bajo control de impulsos, pensamientos autorreferenciales de muerte, signos de rivalidad fraterna, capacidad de juicio social debilitado y dificultades en la capacidad de medición del peligro. Se presume alteración a nivel sensorio-perceptivo, refiriendo que escucha voces que le dicen que se comporte de manera inadecuada. Acude con remisión por especialidad médica de pediatría Dra. Manuela Cecilia López Ramírez (14/05/2025): "paciente con trastorno de aprendizaje que se viene con inicio de pubertad".
DX.: (F813). TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

Se indica cuadro clínico de larga data, con mayor agudización de sintomatología comportamental. Reporta antecedentes de recepción de terapias integrales, sin embargo, se realiza retiro voluntario por apatía del menor al contexto clínico. Actualmente retoma controles con especialidad médica de pediatría. Reporta episodio convulsivo febril a la edad de 18 meses. Niega traumatismos craneoencefálicos con pérdida de la conciencia. **Desarrollo actual:** *audición y visión* se infieren normales, sin realización de exámenes previos. *Habilidades de la vida diaria:* es independiente en tareas de vestido, alimentación, aseo e higiene, aunque se le apoya en tareas de baño. No discrimina el valor de la moneda. *Motricidad:* conservado. *Lenguaje:* conservado. *Sueño:* patrón de sueño alterado, con presencia de insomnio de forma ocasional. *Alimentación:* selectividad alimentaria.

Historia del desarrollo: producto de segunda gesta de la progenitora, embarazo no programado y no deseado. Niega asistencia a controles prenatales. Mantiene regular alimentación. Se desconocen demás antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. Fue encontrado al tercer día de nacido abandonado en el campo con mordeduras de hormigas y quemaduras por exposición al sol. A las 3 semanas es hospitalizado en UCI neonatal durante 2 meses debido a cuadro de neumonía con requerimiento de sonda de gastrostomía (PEG).

Sostén cefálico a los 3 – 4 meses. Sedestación a los 5 meses. Patrón de gateo clásico a los 7 meses. Deambulación a los 11 meses. Control de esfínteres a los 12 meses. Con relación a hitos del desarrollo del lenguaje se reporta balbuceo a los 8 meses. Primeras palabras a los 9 – 10 meses. Construcción de frases a los 12 meses.

Antecedentes personales

Antecedentes patológicos/neurológicos: neumonía, convulsión febril. *Antecedentes quirúrgicos:* niega. *Antecedentes farmacológicos:* niega. *Antecedentes traumáticos:* niega. *Antecedentes tóxicos/alérgicos:* niega. *Antecedentes hematológicos:* niega.

Antecedentes heredofamiliares

Se desconocen antecedentes heredofamiliares.

Historia sociofamiliar: José proviene de familia adoptiva, convive con padres y hermanos, con reporte de dinámica familiar preservada, aunque con presencia de signos de rivalidad fraterna. Ambos padres corresponden a las figuras de autoridad en el hogar, con establecimiento de normas y hábitos básicos que al menor le cuesta seguir. Se hace uso del dialogo, castigos y castigo físico (ocasional) como métodos de disciplina. A nivel socioafectivo refiere signos de irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, llanto fácil y baja construcción de su autoconcepto. Patrón de socialización se infiere preservado con búsqueda espontánea de acercamiento social con pares y adultos.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

Historia escolar: ingresó a un CDI a los 3 años de edad, manteniendo buena adaptación, sin embargo, con evidencia de dificultades en aprendizaje y a nivel de su conducta. Inicia su proceso de escolaridad formal a los 5 años, con reporte de bajo rendimiento escolar que se mantiene hasta la actualidad. Repitió grado quinto de básica primaria. Actualmente se encuentra cursando séptimo grado de básica secundaria, con regular desempeño académico, atención dispersa, dificultades en el seguimiento de instrucciones y desmotivación frente al contexto escolar. **Relatorio escolar (05/06/2025);** “presenta dificultades en varias áreas, incluyendo la inteligencia lingüística, intrapersonal e interpersonal. Tiene dificultad para pronunciar algunas palabras y expresarse oralmente, le cuesta expresar las ideas y emociones, invierte palabras al leer y escribir o hacer dictados, se le dificulta recordar deberes e instrucciones dadas al momento de ejecutar las tareas asignadas, aunque este año ha ido mejorando. Tiene dificultad para identificar y manejar sus emociones y demuestra falta de esfuerzo para garantizar su aprendizaje. Tiene dificultad para interactuar con sus compañeros de manera efectiva, le gusta jugar brusco, le falta ser más organizado con sus útiles escolares y con su sitio de trabajo, se para con frecuencia de su asiento y distrae a sus compañeros, se altera con facilidad y le cuesta manejar la frustración”.

OBSERVACIONES MÉDICAS Y NEUROLÓGICAS

Paciente que ingresa a consultorio por sus propios medios en compañía de su hermana, con vestimenta acorde a sexo, edad y contexto, mostrándose consciente, alerta y vigil. Orientado autopsíquica y alopsíquicamente (tiempo, espacio y persona) con contacto visual disminuido, bajo nivel de interés frente al proceso evaluativo, apatía y carencia de espontaneidad frente a la apertura al diálogo. José, si bien refleja un lenguaje expresivo mayormente fluente y un ajustado uso de estructuras gramaticales, presenta dificultades significativas para expresar sus ideas de forma oral, con tendencia al concretismo y mutismo selectivo, por lo que se le debe instigar de manera recurrente para que logre una mayor participación y amplíe sus respuestas. Por su parte, con relación a aspectos receptivos logra la comprensión del lenguaje oral y de algunos comandos semicomplejos, sin embargo, las instrucciones se le deben reiterar de manera recurrente y requiere de apoyo constante para beneficiar su rendimiento, no obstante, se observa que en algunas tareas responde de manera incongruente o inapropiada frente al contexto solicitado. En dominio atencional se observan signos de atención dispersa y tendencia a la fatiga, resaltándose que, evita activamente tareas que supongan esfuerzos, así como mantiene una baja permanencia en las actividades, puesto que interrumpe sus ejecuciones para realizar dibujos (no solicitados por el evaluador). A nivel comportamental y socioafectivo presenta negativismo y baja tolerancia a la frustración, especialmente frente a la ejecución de pruebas con mayor demanda cognitiva. Teniendo en cuenta el desarrollo de sus habilidades de rendimiento académico se encuentran fallas globales en los dominios de lectura, escritura y aritmética. Mantiene control cefálico, sin embargo, su higiene postural es inadecuada (vicios posturales).

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

IV. PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS APLICADAS

1. **Historia clínica de la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI-2;** caracterización del problema actual, revisión de la historia familiar y médica, incluyendo el embarazo y parto, explorar el desarrollo motor, del lenguaje y otras habilidades del menor.
2. **Escala de inteligencia de Wechsler para niños – WISC-V;** evaluación de la inteligencia y aptitudes intelectuales del menor en el ámbito clínico y psicopedagógico.
3. **Habilidades de rendimiento académico de la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI-2;** evaluación de las habilidades académicas a través de la lectura, escritura, cálculo, atención y funciones ejecutivas.
4. **Lista de Chequeo NEUROPSI con criterios diagnósticos del TDAH;** detección de la posible existencia de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
5. **Inventario de Depresión Infantil – CDI;** evaluación de sintomatología depresiva en el menor.
6. **Inventario de Depresión Estado-Rasgo (IDER);** identificación el grado de afectación (estado) y la frecuencia de ocurrencia (rasgo) del componente afectivo de la depresión.
7. **Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada segunda edición – CMASR-2;** evaluación del nivel y la naturaleza de la ansiedad (problemas de estrés académico, ansiedad ante los exámenes, conflictos familiares, adicciones, conductas perturbadoras, problemas de personalidad, entre otros).

V. RESULTADOS DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS, WISC-V

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

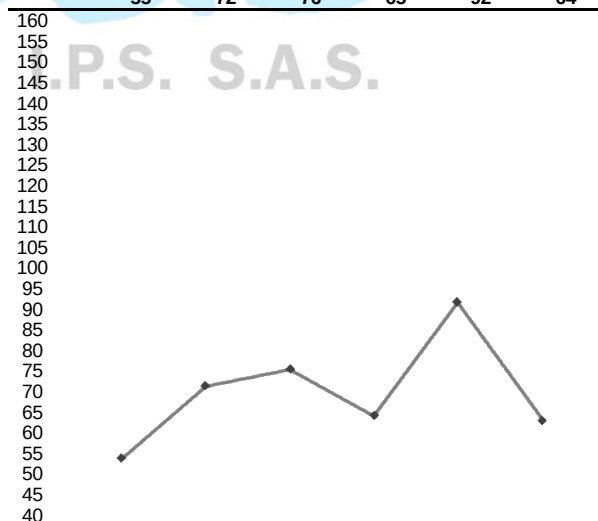
Prueba	PD
Cubos	26
Semejanzas	17
Matrices	15
Dígitos	11
Claves	50
Vocabulario	10
Balanzas	15
Puzles visuales	7
Spam de dibujos	22
Búsqueda de Símbolos	27

Suma puntuaciones escalares

Puntuación escalar					
	7				7
3					3
		6			6
			1		1
				8	8
1					1
		6			6
	3				(3)
			6		(6)
				9	(9)
4	10	12	7	17	32
Comp. Verbal	Visoes-pacial	Razon. Fluido	Mem. Trabajo	Vel. Proces.	Escala total

Perfil de puntuaciones compuestas

	ICV	IME	IRF	IMT	IMP	CIT
	55	72	76	65	92	64



CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta	Rango Percentil	Intervalo de confianza	
				95%	
Comprensión Verbal	4	ICV	55	0,1	51-69
Visoespacial	10	IVE	72	3	66-83
Razonamiento fluido	12	IRF	76	5	70-85
Memoria de trabajo	7	IMT	65	1	60-76
Velocidad de procesamiento	17	IVP	92	30	84-102
Escala total	32	CIT	64	1	60-72

PUNTUACIÓN	DESCRIPCIONES CUALITATIVAS
> 130	Muy alto
120 – 129	Alto
110 – 119	Medio alto
90 – 109	Medio
80 – 89	Medio bajo
70 – 79	Bajo
< 69	Muy bajo (D.I.)

Teniendo en cuenta los resultados de la escala de inteligencia para niños WISC-V, José obtiene **un coeficiente intelectual de 64 puntos**, interpretado como un **nivel de inteligencia muy bajo**, el cual con un intervalo de confianza del 95% podría ubicarse en un rango entre 60-72 e indica un desempeño significativamente inferior al esperado para su grupo etario. Este resultado sugiere la presencia de importantes **limitaciones en las habilidades cognitivas generales**, que afectan de forma directa su desempeño académico, adaptativo y su capacidad para enfrentar las exigencias escolares y sociales cotidianas. Se resalta que, al realizar el análisis primario de los resultados se observa un perfil heterogéneo con discrepancias estadísticamente significativas entre área de velocidad de procesamiento (IVP=92) y comprensión verbal (ICV=55), por lo cual se sugiere tener precaución al momento de interpretar su C.I global (medida no fiable) y realizar una descripción cualitativa de los índices de forma individual para identificar fortalezas y debilidades normativas en su perfil cognitivo.

La descripción de hallazgos relevantes para cada índice se describe a continuación:

Índice de Comprensión Verbal (ICV):

El índice de ICV evalúa la capacidad de José para razonar con material verbal, comprender conceptos verbales, pensar con palabras y expresar pensamientos de manera significativa. El puntaje obtenido se ubica en un rango **muy bajo** (55 puntos) y corresponde al **punto más debilitado de su perfil cognitivo**, sugiriendo dificultades severas en el dominio del lenguaje receptivo y expresivo, así como limitaciones en vocabulario, razonamiento verbal, conocimientos adquiridos y la comprensión de relaciones lógicas entre palabras o conceptos, lo que puede impactar su capacidad para comprender instrucciones, seguir consignas escolares, responder preguntas de forma adecuada y adquirir nuevos conocimientos mediante el lenguaje oral.

Índice Visoespacial (IVE):

El área visoespacial evalúa la capacidad para analizar, comprender y reproducir relaciones espaciales visuales, así como el manejo de tareas que implican coordinación visomotriz. El

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

desempeño **bajo-limítrofe** (72 puntos) indica que José presenta dificultades en la organización perceptiva, análisis visual y construcción de diseños complejos, lo cual puede traducirse en problemas para realizar tareas escolares que demanden copiar gráficos, organizar materiales, resolver problemas con figuras geométricas, o seguir instrucciones con componentes espaciales.

Índice de Razonamiento Fluido (IRF):

Este índice mide la capacidad para identificar patrones, relaciones y reglas lógicas, así como el pensamiento abstracto. El puntaje obtenido se ubica en un nivel **bajo-limítrofe** (76 puntos) señala limitaciones en el razonamiento inductivo y deductivo, lo cual puede afectar la resolución de problemas nuevos, la capacidad para establecer relaciones conceptuales y el aprendizaje de conceptos matemáticos o científicos.

Índice de Memoria de Trabajo (IMT):

El área de MT refleja la capacidad de José para retener y manipular información de manera temporal, siendo fundamental para realizar cálculos mentales, seguir secuencias de instrucciones, mantener la atención sostenida y organizar ideas. Un desempeño **muy bajo** (65 puntos) sugiere que el menor presenta dificultades significativas para retener información en su mente mientras realiza una tarea, lo que puede impactar de forma significativa su rendimiento en lectura, escritura y matemáticas, así como su desempeño cotidiano en tareas que requieren seguimiento de varios pasos.

Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP):

El IVP evalúa la rapidez y precisión con la que se procesan estímulos visuales simples. Su desempeño se encuentra dentro del rango **promedio** (92 puntos), lo cual indica que José puede procesar información visual simple con una velocidad y precisión adecuadas, siempre que las demandas de memoria, lenguaje o razonamiento no sean altas. Esta **fortaleza relativa** podría ser utilizada como un punto de apoyo para compensar otras áreas deficitarias, por ej., mediante el uso de apoyos visuales estructurados.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

HABILIDADES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ENI-2

Percentil	Lectura			Escritura			Aritmética				Puntuación estándar	CLASIFICACIÓN
	Precisión	Comprensión	Velocidad	Precisión	Composición narrativa	Velocidad	Conteo	Manejo numérico	Cálculo	Razonamiento lógico-matemático		
99											140	Superior
99											135	
98											130	
95											125	Promedio alto
91											120	
84											115	
75											110	Normal o promedio
63											105	
50											100	
37											95	
26											90	
16											85	Promedio bajo
9											80	Límite
5											75	
2											70	
1											65	Muy bajo
0.4											60	
0.1											55	
<0.1											<51	

Lectura

El patrón de resultados evidencia un proceso lector comprometido, con **deficiencias significativas** tanto en la mecánica (**precisión**) como en el acceso al significado (**comprensión**), y una fluidez que, aunque se mantiene dentro de límites funcionales bajos, no logra compensar las debilidades estructurales del sistema lector. La **precisión lectora** se ubica rendimiento **muy bajo** (centil <0.1) indicando serias dificultades en los procesos de decodificación, que muestran que, José aún no ha consolidado mecanismos automatizados para la lectura precisa, por lo cual se observa una lectura con errores frecuentes (omisiones, sustituciones, inversiones), dificultades con palabras de baja frecuencia o complejas y dependencia de estrategias poco eficaces, como la adivinación por contexto.

Por su parte, en cuanto a la **comprensión** la puntuación **muy baja** (centil 0.4) indica que el menor tiene severas dificultades para comprender lo que lee, lo cual puede estar influido tanto por la baja precisión en la decodificación como por limitaciones en el razonamiento verbal, por ello, le cuesta captar las ideas principales o los detalles relevantes, no logra realizar inferencias, establecer relaciones causales y anticipar desenlaces, presentando respuestas vagas, imprecisas o erróneas a preguntas sobre los textos leídos y manteniendo fallas en el seguimiento de instrucciones dadas por la lectura de oraciones. Finalmente, a nivel de la **velocidad lectora** su desempeño es **promedio bajo** (centil 16), indicando que su velocidad de lectura está levemente por debajo del promedio esperado para su edad. Este resultado, si bien es relativamente mejor que los otros componentes,

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

no implica un proceso lector eficiente. En contextos como este, una velocidad levemente adecuada podría estar compensada por una baja precisión, es decir, José lee a un ritmo que podría parecer aceptable, pero cometiendo múltiples errores que distorsionan el sentido del texto.

Escritura

El patrón de desempeño de en su perfil escritor sugiere la presencia de **alteraciones marcadas** en los **procesos de escritura**, afectando la forma (caligrafía, ortografía, grafomotricidad), el contenido (estructura narrativa, coherencia, productividad) y el ritmo (automatización y velocidad). En tareas de **precisión** el resultado **muy bajo** (centil 1), exhibe dificultades en los mecanismos básicos del proceso escritural, las cuales se manifiestan como errores ortográficos frecuentes (omisión, sustitución o adición de letras, omisión de acentos, espacios añadidos), letra desorganizada, con signos de macrografía (trazos grandes), bajo control visomotor en la escritura, que afecta la direccionalidad, la alineación y la consistencia gráfica, así como irrespeto por los márgenes o líneas del plano gráfico, lo cual compromete la legibilidad del texto. Se destaca que este tipo de errores refleja fallas en la codificación ortográfica y ejecución motora fina, debilidades visoespaciales, funciones grafomotoras alteradas y pobre automatización de la escritura.

En conjunto, a nivel de las tareas de **composición narrativa** su rendimiento **muy bajo** (centil <0.1), sugiere baja capacidad para elaborar un texto escrito con sentido, respetando una estructura narrativa básica (inicio, desarrollo, desenlace), coherencia temática y correcta organización de ideas. Se destaca que José se muestra incapaz de realizar dichas tareas (coherencia narrativa = grado 0, no escribe ninguna palabra asociada al cuento "Bolita de nieve"), lo que implica fallas significativas en la evocación léxica escrita, déficits atencionales, mnésicos y de planificación ejecutiva, desorganización en la secuencia de ideas, inhibición frente a la demanda escolar, posiblemente exacerbada por experiencias previas de frustración, baja autoestima académica y desmotivación, y falta de dominio de las reglas básicas de redacción (uso de conectores, puntuación, desarrollo temático o coherencia textual).

Finalmente, un desempeño **muy bajo** (centil <0.1) en tareas de **velocidad**, indica una escritura extremadamente lenta con pobre fluidez y evidente fatiga durante la ejecución de la tarea, lo cual compromete directamente la productividad académica en actividades cotidianas como tomar apuntes, copiar del tablero o desarrollar evaluaciones escritas.

Aritmética

El perfil aritmético de José indica una **afectación global** en las **habilidades matemáticas**, manteniendo mayor compromiso en los niveles de comprensión conceptual, razonamiento lógico y cálculo, y un desempeño levemente menos afectado, aunque aún deficitario, en el conteo. Por lo anterior, a nivel de **conteo** se encuentra una puntuación **límite** (centil 5), que sugiere que el menor ejecuta esta habilidad básica con dificultades, evidenciando retrasos en la adquisición de la

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

secuencia numérica automatizada, errores en la omisión o repetición de números y dificultades para mantener la atención sostenida durante las tareas de conteo.

Conjuntamente, en cuanto a las habilidades de **manejo numérico** la puntuación es **muy baja** (centil <0.1), lo cual muestra una afectación severa en la comprensión del valor numérico y su uso funcional, evidenciándose en José dificultades para distinguir entre unidades, decenas y centenas, bajo manejo de la terminología mayor que y menor que (incapacidad para ordenar o comparar cantidades) y fallas en la representación mental del sistema decimal. Lo anterior, afecta directamente la capacidad de **cálculo** (mental y escrito), donde también alcanza un rendimiento **muy bajo** (centil <0.1), que deja en evidencia una falta de automatización de las tablas básicas y procedimientos operativos, dificultades atencionales y mnésicas que interfieren en el almacenamiento y recuperación de información numérica y errores en la alineación de cifras o en la comprensión del procedimiento, especialmente en operaciones de varios pasos.

Finalmente, el razonamiento **lógico-matemático** se ubica en un rango **muy bajo** (centil 1), lo cual refleja que José presenta serias limitaciones para razonar y resolver problemas que impliquen planificación, comprensión de situaciones y análisis secuencial, en este sentido, se mantiene con dificultades para entender el planteamiento del problema o su relación con operaciones específicas, debilidad para identificar los datos relevantes y la estrategia adecuada, dependencia de procedimientos inadecuados o de ensayo-error, y presenta un estilo cognitivo más concreto, con poca flexibilidad para el uso de estrategias alternativas.

ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS REVISADA SEGUNDA EDICIÓN – CMASR-2

PERFIL MASCULINO EDAD: 9 A 14 AÑOS			
ESCALAS	JOSÉ MAKU GUERRA EDAD 13 AÑOS	PUNTUACIÓN T	CLASIFICACIÓN
Defensividad	4	42	No más ansioso que la mayoría
Total de ansiedad	27	52	No más ansioso que la mayoría
Ansiedad fisiológica	10	44	No más ansioso que la mayoría
Inquietud	6	51	No más ansioso que la mayoría
Ansiedad social	11	58	No más ansioso que la mayoría

TABLA PARA LA PUNTUACIÓN NORMALIZADA EQUIVALENTE	
PUNTUACIÓN T	CLASIFICACIÓN
71 y mayor	Extremadamente ansioso
61-70	Moderadamente ansioso
40-60	No más ansioso que la mayoría
39 y menor	Menos ansioso que la mayoría

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

El perfil emocional obtenido en la CMAS-R2 muestra un nivel global de ansiedad dentro del rango normativo (**no más ansioso que la mayoría**), sin evidencia de sintomatología ansiosa clínica (ausencia de signos significativos relacionados con ansiedad física e inquietud). Sin embargo, se identifican **rasgos moderadamente elevados de ansiedad social**, reportando aspectos como temor a cometer errores delante de los demás o hacer el ridículo, inseguridad en situaciones sociales nuevas o con figuras de autoridad y tendencia al retraimiento o a la evitación de interacciones sociales evaluativas (como por ej., exponer en clase, leer en voz alta o participar en juegos grupales) o en contextos altamente demandantes desde lo interpersonal.

INVENTARIO DE DEPRESIÓN ESTADO/RASGO – IDER

TABLA DE PUNTAJES – IDER					
ESTADO			RASGO		
ESCALAS	P.D	P. CENTIL	ESCALAS	P.D	P. CENTIL
Eutimia	14	90	Eutimia	16	98
Distimia	12	95	Distimia	12	90
Total	26	95	Total	28	96

Interpretación: las puntuaciones inferiores al percentil 75 se consideran **normales**, mientras que las puntuaciones superiores al percentil 75 indican **presencia de depresión**.

Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en el inventario IDER se encuentran **centiles significativos (altos)** en **escalas de eutimia y distimia (estado-rasgo)**, lo que sugiere que en José se encuentra la presencia de reacciones emocionales negativas de carácter temporal que se asocian con eventos que generan sensación de malestar general, miedo, tristeza, ansiedad, hostilidad, disgusto y soledad; observándose además, sentimientos de desesperanza, incluso en ausencia de eventos a los que puedan atribuirse dichos sentimientos, lo cual genera una interpretación adversa de las distintas situaciones cotidianas y supone un incremento en la posibilidad de responder cognitiva, afectiva y conductualmente de forma negativa, mostrándose con pérdida del interés, anhedonia (disminución de la capacidad para experimentar placer), bajo nivel de energía, pérdida del entusiasmo, disminución en el nivel de alerta mental y pobre esperanza frente al futuro. Esto genera vulnerabilidad frente al desarrollo de reacciones depresivas y cuadros psicopatológicos del estado de ánimo, asociado a una actitud pesimista, intranquila y de malestar que acompaña a las circunstancias vitales durante la mayor parte del tiempo, asociándose con características estables de su personalidad.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL – CDI

PERFIL INDIVIDUAL				
PC	Disforia	Autoestima	CDI total	PC
99				99
98				98
97				97
96	17	14	31	96
95				95
90				90
85				85
80				80
75				75
70				70
65				65
60				60
55				55
50				50
45				45
40				40
35				35
30				30
25				25
20				20
15				15
10				10
0-5				0-5

Severa

Leve

Sin
sintomatología

En inventario de depresión infantil José alcanza una puntuación total de **31 puntos** ubicada en un percentil de **97 (depresión severa)**, lo cual indica la presencia de un **cuadro depresivo de severidad clínica**, con afectación marcada del estado de ánimo, caracterizado por disforia intensa, alteración en la autoestima y el autoconcepto, y baja motivación general hacia el entorno, especialmente en el ámbito escolar. De acuerdo con lo reportado se encuentran signos que requieren atención clínica prioritaria para disminución de riesgos y consecuencias funcionales: sentimientos de tristeza, inseguridad frente al futuro, pensamientos de que todo lo hace mal, baja capacidad de experimentación del placer (anhedonia), autopercepción de que es malo, preocupaciones recurrentes acerca de que le ocurran cosas malas, odio hacia sí mismo, pensamientos autorreferenciales de muerte sin intención de ejecutarlos (piensa en matarse, pero no lo haría), preocupaciones excesivas, inhibición y retraimiento, incapacidad para tomar decisiones, dificultades para la realización de sus deberes, alteración en patrón del sueño, fatiga/cansancio la mayoría de los días, disminución del apetito, preocupaciones acerca del dolor y la enfermedad, sentimientos de soledad, desmotivación y apatía frente al contexto escolar, necesidad de tener mayor número de amigos, bajo rendimiento académico, sensación de que no es tan bueno como los jóvenes de su edad, dificultades en el seguimiento

de instrucciones y presencia de peleas recurrentes.

LISTA DE CHEQUEO DEL NEUROPSI CON CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

CUESTIONARIO PARA PADRES				
Síntomas de déficit de atención	SI	NO	Frecuencia	Puntuación
No presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades			Casi siempre	3
Tiene dificultades para sostener la atención en las tareas y en los juegos			Casi siempre	3
No parece escuchar lo que se le dice			Casi siempre	3
No sigue las instrucciones o no termina las tareas en la escuela o actividades en la casa a pesar de comprender órdenes			Casi siempre	3
Tiene dificultades para organizar sus actividades			Casi siempre	3
Evita hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzos			Casi siempre	3
Pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades			Casi siempre	3

Centro de Rehabilitación y Educación Especial ARSAS IPS S.A.S/Dir: Carrera 17 N° 18-55 B. Guatapurí
Nit: 824.003.324-4/Cámara de Comercio N° 00058870/Tel: 5819838

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes			Casi siempre	3
Es olvidadizo en las actividades de la vida diaria			Casi siempre	3
Síntomas de hiperactividad – impulsividad	SI	NO	Frecuencia	Puntuación
Molesta moviendo las manos y los pies mientras está sentado			Algunas veces	1
Se levanta de su asiento en clase o en otras situaciones donde debe estar sentado			Muchas veces	2
Corretea y trepa en situaciones inadecuadas			Algunas veces	1
Tiene dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto			Algunas veces	1
Está permanentemente en marcha como si tuviera un motor dentro			Algunas veces	1
Habla demasiado			Algunas veces	1
Contesta o actúa antes de que se le terminen de hacer las preguntas			Muchas veces	2
Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos			Algunas veces	1
Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás			Algunas veces	1
Puntaje DA:				27
Puntaje HI				11

CUESTIONARIO PARA DOCENTES				
Síntomas de déficit de atención	SI	NO	Frecuencia	Puntuación
No presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades			Muchas veces	2
Tiene dificultades para sostener la atención en las tareas y en los juegos			Muchas veces	2
No parece escuchar lo que se le dice			Casi siempre	3
No sigue las instrucciones o no termina las tareas en la escuela o actividades en la casa a pesar de comprender ordenes			Algunas veces	1
Tiene dificultades para organizar sus actividades			Muchas veces	2
Evita hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzos			Algunas veces	1
Pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades			Algunas veces	1
Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes			Muchas veces	2
Es olvidadizo en las actividades de la vida diaria			Casi siempre	3
Síntomas de hiperactividad – impulsividad	SI	NO	Frecuencia	Puntuación
Molesta moviendo las manos y los pies mientras está sentado			Muchas veces	2
Se levanta de su asiento en clase o en otras situaciones donde debe estar sentado			Algunas veces	1
Corretea y trepa en situaciones inadecuadas			Muchas veces	2
Tiene dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto			Casi siempre	3
Está permanentemente en marcha como si tuviera un motor dentro			Muchas veces	2
Habla demasiado			Muchas veces	2
Contesta o actúa antes de que se le terminen de hacer las preguntas			Muchas veces	2
Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos			Muchas veces	2
Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás			Muchas veces	2
Puntaje DA:				17
Puntaje HI				18

TABLA DE CLASIFICACIÓN NIVELES DE RIESGO	
PUNTUACIÓN TOTAL	CLASIFICACIÓN
6 a 8 puntos	Riesgo leve
9 a 11 puntos	Riesgo moderado
>12 puntos	Riesgo severo

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo con la escala de inteligencia para niños WISC-V aplicada al menor José Luis Miguel Maku Guerra Martínez se identifica **una capacidad intelectual total de 64 puntos**, correspondiendo a un **nivel de inteligencia muy bajo** que sugiere un **ritmo de aprendizaje comprometido para su edad** (ritmo lentificado e inconsistente), denotando **afectación significativa** en los índices de **comprensión verbal, memoria de trabajo y razonamiento**

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

visoespacial-fluido, destacándose un **rendimiento relativamente conservado** en **velocidad de procesamiento** (rango promedio = 92 puntos).

A nivel funcional, teniendo en cuenta su perfil cognitivo actual se identifican **afectaciones importantes** en **procesos atencionales**, **memoria de trabajo**, **razonamiento verbal**, **razonamiento abstracto**, **percepción espacial**, **discriminación visual**, **coordinación visomotora**, **pensamiento lógico** y **velocidad de respuesta**, lo cual interfiere directamente en la adquisición y consolidación de aprendizajes escolares, en el seguimiento de instrucciones, en la organización y planificación de actividades, así como en el control inhibitorio. Estas dificultades se expresan clínicamente en un comportamiento desorganizado, con distracción frecuente, impulsividad, baja tolerancia a la frustración y desmotivación escolar constante, compatibles con un **Trastorno por déficit de atención/hiperactividad de tipo combinado (TDAH)**, tal como se sustenta en los resultados obtenidos en las listas de criterios para el Dx. del TDAH aplicadas a los contextos escolar y familiar, donde obtiene **niveles de riesgo** que fluctúan entre los rangos **moderado a severo** frente a la experimentación de sintomatología de **inatención** e **hiperactividad/impulsividad** (generalización de conductas en más de 1 contexto), generando malestar significativo en su funcionamiento social, escolar y familiar.

Por su parte, con relación al desarrollo de sus habilidades conceptuales, se observaron **dificultades severas** en **lectura**, **escritura** y **matemáticas**, con presencia de errores persistentes en decodificación, comprensión lectora, estructuración narrativa, fluidez escritora, manejo numérico, cálculo básico y razonamiento lógico-matemático, lo cual permite establecer un perfil cognitivo se asemeja a características halladas en niños con trastorno específico del aprendizaje con dificultad global (mixto), sin embargo, en función de su C.I actual (64 puntos) no cumpliría con el criterio D. que indica que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, por lo cual, posterior a proceso de intervención se sugiere revalorar su CIT para descartar presencia de un Trastorno del Desarrollo Intelectual.

En esfera emocional, la administración de instrumentos como el CDI, IDER y CMAS-R2 revela un cuadro de afectividad alterada, con **indicadores que se ubican en el rango clínico de depresión severa**, tanto a nivel de estado como de rasgo. Se identifican signos de **disforia intensa**, **autoestima deteriorada**, **desesperanza**, **sentimientos de soledad** y presencia de **pensamientos autorreferenciales de muerte** (aunque sin intencionalidad de ejecutarlos), entre otros. Así mismo, presenta también un perfil de **ansiedad social moderadamente elevado**, que podría amplificar su retraimiento, inseguridad y baja participación en el contexto escolar.

Contextualmente, se identifica como un elemento emocionalmente relevante el hecho de que el menor ha conocido su condición de adopción, lo cual ha generado una reactivación de conflictos identitarios y emocionales, vinculados a sentimientos de inseguridad, confusión, tristeza o posible

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

desorganización interna, los cuales requieren acompañamiento psicoterapéutico. Por otra parte, se reporta rivalidad fraterna específica hacia su hermana, expresada en comportamientos competitivos o disruptivos.

Por lo anterior, en conjunto, teniendo en cuenta los antecedentes del menor, la observación clínica y los hallazgos obtenidos en la evaluación neuropsicológica configuran un perfil clínico complejo, con alteraciones cognitivas, emocionales y contextuales significativas, que requieren intervención clínica interdisciplinaria, psicoeducación familiar, ajustes pedagógicos y acompañamiento terapéutico continuo, destacándose que, el abordaje integral de estos factores es fundamental para favorecer la estabilización emocional, la construcción de una narrativa identitaria saludable, el fortalecimiento del vínculo familiar y el desarrollo de una trayectoria escolar adaptada a sus necesidades particulares.

VII. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

(F90.2). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad, presentación combinada. **(F32.2).** Episodio depresivo grave. *Obs. del Dx.:* capacidad cognitiva muy baja. Historia de adopción y ajuste psicológico secundario a revelación reciente. **(Z601).** Problemas relacionados con situación familiar atípica. **(F933).** Trastorno de rivalidad entre hermanos. **(Z55.3).** Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar.

VIII. CONDUCTA A SEGUIR

- **Psicología – Terapia sistémica / familiar** (12 sesiones por 3 meses – 1 sesión semanal).
 - ⇒ Iniciar proceso de psicoeducación con pautas para manejo de cuadro clínico presente en el menor.
 - ⇒ Explorar el impacto emocional de la revelación de la adopción en el menor y acompañar el proceso de elaboración identitaria.
 - ⇒ Establecer canales de comunicación empática entre los miembros del sistema familiar, promoviendo la escucha activa y la expresión emocional adecuada.
 - ⇒ Abordar la rivalidad fraterna y establecer reglas de convivencia que promuevan el respeto y la cooperación entre hermanos.
 - ⇒ Promover una parentalidad afectiva, reguladora y no coercitiva, enfocada en el fortalecimiento del apego seguro.
- Evaluación ****prioritaria**** por **psicología clínica infanto-juvenil**; con la finalidad de evaluar perfil completo emocional del menor y aplicar inventario de personalidad para adolescentes.
- **Psicología clínica infantil y del adolescente** (12 sesiones por 3 meses – 1 sesión semanal).
 - ⇒ Intervenir síntomas depresivos presentes en el menor.
 - ⇒ Desarrollar estrategias de autorregulación emocional ante frustraciones, conflictos o sobrecargas cognitivas.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

- ⇒ Abordar la vivencia del proceso adoptivo, promoviendo una narrativa personal coherente y resiliente.
- ⇒ Estimular la expresión verbal de emociones como alternativa a conductas de autoagresión.
- ⇒ Promover habilidades sociales y reforzamiento positivo de logros para mejorar la autoestima y el sentido de competencia personal.
- ⇒ Acompañar el proceso psicoeducativo sobre TDAH y desarrollar rutinas de autocontrol y atención sostenida.

Nota: debido a la gravedad de la sintomatología emocional y comportamental reportada, la intervención debe realizarse por la especialidad de psicología clínica infantil, más allá de realizarse con psicología general.

- **Terapia ocupacional** (24 sesiones por 3 meses – 2 sesiones semanales).
 - ⇒ Estimulación de dispositivos básicos del aprendizaje – DBA y funciones cerebrales superiores.
 - ⇒ Fortalecer la permanencia en las tareas.
 - ⇒ Iniciar proceso de orientación vocacional y construcción de proyecto de vida.
 - ⇒ Fortalecer habilidades de planeación y organización secuencial a través de actividades estructuradas y lúdicas.
 - ⇒ Desarrollar rutinas de trabajo autónomo que favorezcan la autorregulación en tareas escolares.
 - ⇒ Promover el uso funcional del espacio gráfico y la estructuración del plano escrito mediante técnicas visuales, lineamientos y entrenamiento dirigido.
- **Fonoaudiología** (24 sesiones por 3 meses – 2 sesiones semanales).
 - ⇒ Estimular el desarrollo de la conciencia fonológica y la asociación grafema-fonema para mejorar la precisión lectora.
 - ⇒ Reforzar la comprensión lectora a través de estrategias de inferencia, síntesis y reformulación oral.
 - ⇒ Intervenir sobre la estructuración del discurso narrativo escrito mediante guías visuales y esquemas de planificación.
 - ⇒ Promover la mejora del vocabulario expresivo y del uso adecuado de estructuras gramaticales en la expresión oral y escrita.
- Evaluación por **neuropsicología** en 18 meses para reevaluar perfil cognitivo, comportamental y emocional con relación a avances alcanzados en proceso terapéutico. Es importante revalorar su C.I para definir o descartar presencia de Déficit cognitivo leve.

IX. RECOMENDACIONES GENERALES

Núcleo familiar:

- Se recomienda estructurar el ambiente en casa, a través del establecimiento de hábitos, rutinas, planificación, horarios y normas, para ello, se sugieren planificar actividades semanales y/o mensuales y hacer uso de calendarios donde se encuentren las tareas a realizar indicando a

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

qué hora deben realizarse, este calendario debe ser colocado en un lugar visible para el menor y debe ser supervisado con la finalidad de corroborar que se estén cumpliendo las tareas.

- Imparta normas claras en el hogar, establezca límites para que José tenga una referencia acerca de lo que puede y no puede hacer. Deben contemplarse consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. Mantenga pautas de crianza congruentes.
- Las instrucciones deben ser claras. Se recomienda dar las instrucciones con el menor cerca, evitando llamarlo por ej., cuando él está en otra habitación.
- Se deben reforzar aquellas conductas adecuadas y positivas. Resalte los avances que tenga José a nivel escolar, afectivo y comportamental, aunque estos sean mínimos.
- Haga uso de contratos conductuales, para ello, establezca un contrato escrito con José firmado por usted y él, donde se contemple lo que se conseguirá por emitir conductas deseadas. Visitar los siguientes recursos online:
 - * <https://www.psicologia-online.com/contratos-conductuales-y-sistemas-de-organizacion-de-contingencias-2182.html>
 - * <https://www.quiainfantil.com/adolescencia/comunicacion-y-socializacion/contrato-conductual-para-mejorar-el-comportamiento-de-adolescentes/>
<https://www.orientacionandujar.es/2020/01/02/diferentes-modelos-de-contratos-conductuales/>
- Realice entrenamiento/estimulación de los dominios cognitivos a través del juego, por ej., sopas de letras, crucigramas, juegos de cartas, ajedrez, parques, dominós, laberintos, rompecabezas, adivinanzas y acertijos. Trabaje especialmente dominio atencional, puede hacer uso de los siguientes recursos gratuitos:
 - * https://drive.google.com/file/d/13guV_ELpbkgMsxH1KNOfefXMhSBqX42t/view
 - * https://drive.google.com/file/d/1UduZaeTD1_fznDuKNUWGq65yGuA3m8md/view
 - * <https://drive.google.com/file/d/1x5SUUe1bWkUwPY10iw3pNjpmehYaCJqu/view>
 - * https://drive.google.com/file/d/1_em7nEP81eBL8KfrpnK3w578Y8GB0BL7/view
 - * <https://drive.google.com/file/d/18F8BcYudijyDRI8xTXbBuP3RUDZAxyc0/view>
 - * https://drive.google.com/file/d/11FqpHrrfKH_KF7esPeFZf72wemeiK_QK/view
 - * <https://drive.google.com/file/d/1xSMtrQiZU3UYHdXSPswbt0HDQPEG9KFf/view>
 - * https://drive.google.com/file/d/1uRvZCt_t9SoSekwYWQ2Hemza-qGn5n8E/view
 - * <https://drive.google.com/file/d/19c8G1Vqwl1DdJxT0bWf33MuHgDOI2tF/view>
- Descubra las actividades del hogar que sean más relajantes para José y ustedes como familia. Compartan tiempo de calidad con él realizando actividades que sean de su agrado.
- Fomente el desarrollo de habilidades sociales a través de la socialización con pares, así como la participación en actividades culturales, comunitarias y deportivas.
- Sea un modelo para José a nivel emocional, incluso cuando usted cometa errores, enséñelos y que él observe cómo los corrige. Asegúrese de ser un modelo seguro, estable y coherente.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

- Valide verbalmente sus emociones sin juicio ni minimización, especialmente cuando exprese tristeza, rabia o confusión sobre su origen adoptivo.
- Evite el uso de gritos, castigos físicos o descalificaciones, ya que estos refuerzan la baja autoestima y la impulsividad.
- Es necesario practicar escenarios de yoga o relajación.
- Se recomienda dar continuidad a la práctica del deporte. Pues la realización de actividad física puede ayudar a José a:
 - * Aumentar su capacidad atencional.
 - * Incrementar su autocontrol (conductual y emocional).
 - * Mejorar su capacidad para resolver conflictos.
 - * Eliminar la frustración ante cualquier fracaso que pueda acontecer.
 - * Reducir los niveles de estrés.
 - * Aumentar su autoestima.
 - * Mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales.
- Se debe reducir al máximo el tiempo de uso frente a las pantallas (teléfono celular, computadora, TV, Tablet, videojuegos).
- José debe mantener una dieta equilibrada/balanceada, además, es importante que se promuevan medidas de higiene del sueño (por ej., organizar un buen ambiente para dormir, evitar o limitar la televisión y videojuegos cerca a la hora de dormir, realizar actividad física durante el día, seguir horarios regulares para dormir, disminuir los ruidos externos, bloquear cualquier acceso de luz, evitar la actividad física y mental excesiva horas antes de dormir, darse una ducha con agua tibia antes de acostarse).
- Facilite el acceso regular a procesos terapéuticos (psicoterapia y terapia familiar) como red de apoyo y herramienta de acompañamiento emocional.

Institución Educativa:

- Se debe contar con normas claras al interior del aula de clases. Defina normas claras e infórmelas oportunamente y sea coherente con su aplicación, se puede hacer partícipe a José y demás compañeros de la elaboración de las mismas.
- Organice la estructura del aula de clases, disminuyendo estímulos que puedan ser distractores dentro de su proceso de aprendizaje. Se recomienda sentar a José en la primera o segunda fila de clase, cerca de usted como docente y alejado por ej., de puertas y ventanas.
- Es importante que las tareas se presenten de forma novedosa.
- Repita las instrucciones de manera oral y escríbalas en la pizarra. Así mismo, pídale que repita las instrucciones dadas para corroborar que haya recibido y comprendido de forma óptima el mensaje.
- Plantee preguntas frecuentes durante las explicaciones y ofrézcale a José una retroalimentación inmediata a sus respuestas.

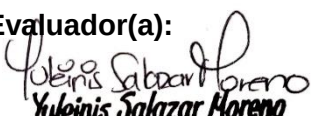
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

ARSAS IPS.S.A.S.

NIT: 824.003.324-4

- Haga contacto visual con José, capte su atención antes de brindarle nueva información.
- Utilice instrumentos y formatos varios de evaluación, en este sentido, se pueden combinar pruebas orales y escritas, de respuesta múltiple, entre otros.
- Enséñele a esquematizar y subrayar, es importante que José pueda tener una mejor estructuración frente a las temáticas aprendidas.
- Asigne actividades donde cumpla funciones propias del grupo, como por ej., encargado de la distribución de libros en el salón y tareas de liderazgo.
- Incentive la participación de José en clase y use experiencias prácticas para garantizar un mejor aprendizaje.
- Evite la exposición oral no preparada (como leer en voz alta o responder espontáneamente frente al grupo), para prevenir ansiedad social y frustración.
- Evite exponer a José, ridiculizarlo o etiquetarlo bajo cualquier circunstancia. En este sentido, es importante evitar reprimendas públicas o comparaciones académicas con compañeros.
- Use una comunicación asertiva o afirmativa, de forma clara, razonable, directa y respetuosa y serena. No tenga miedo de hacer uso de la autoridad. Tampoco utilice una comunicación agresiva que falte al respeto, minimice o humille, evite utilizar patrones de comunicación negativa, como por ej., criticar, censurar, recriminar o acusar.
- Vigile su comportamiento de forma constante.
- Resalte las cosas que hace bien (sus puntos fuertes) y fomente que realice actividades donde sea competente y disfrute. Es importante que se hagan observaciones positivas sobre su trabajo, sin dejar de señalar aquello en lo que necesita mejorar.
- Permítale trabajar en equipo (ubíquelo en un grupo que lo apoye) y ajuste las clases de manera que pueda participar con sus demás compañeros.
- Favorezca la participación en actividades lúdico-creativas, donde pueda expresarse sin presión evaluativa (arte, música, dramatización).
- Trabaje en el fortalecimiento de la educación emocional y el control de impulsos.
- Trabaje con el equipo de orientación escolar la contención emocional dentro del aula, brindando espacios de escucha individualizada.
- Mantengan contacto permanente con núcleo familiar del menor y profesionales terapeutas involucrados en el proceso.

Evaluator(a):


Yuleinis Salazar Moreno
Yuleinis Salazar Moreno
Psicóloga esp. en Neuropsicología Clínica
Colegio Colombiano de Psicólogos
REG. MÉDICO: TP. 199719